PORT FOLIO



ญาณภัทร พินิจพิชิตกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

CURRICULUM VITAE



YANAPHAT PINIJPICHITKUL

MD Candidate · MSc Biomedical Engineering (MAP-C) · Health Business Management (CMMU) · Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Six years of medicine, two master's degrees, three startups. Every one of them points back to obstetrics and gynaecology, and to what it could become.

3	4 +1	4
Medical Technology Startup Founder	Research	International Elective

MEDICAL INNOVATION STARTUP

TRAWELL

Founder & CEO — health travel tech startup, ideation stage

Qualified, Startup Thailand League · NIA grant

UNITE

Founder & Team Lead — med-edtech startup, prototype stage
Winner, UniHack 2021

PodiPatch

Co-Founder & Team Lead — microneedle dressing for diabetic foot ulcers

Winner, MDCU Pitching Challenge · Grand Finalist, NUS Medical Grand Challenge

Nirvamed

Business & Product Design Intern — cardiac catheter startup, 2024–present

LEADERSHIP

- 2024/25 — President & Founder, SIOGC
- 2023/24 — VP & Co-Founder, Global Health Club
- 2024 — Tech Chair, Siriraj Student Union

INTERNATIONAL CLINICAL ELECTIVES

- 2023 — IFMSA Research Exchange — Marseille, France
- 2025 — NUH Singapore — Clinical Exchange
- 2025 — Saw swee hock school of Public Health, NUS
- 2027 — Duke University, USA — OB/GYN Elective

SKILLS

Python · MySQL · Full-Stack Dev · Lean Management · Data Analysis

Thai (native) · English — **TOEFL iBT 110/120, TOEIC 985/990**

Research & publications

Maternal & neonatal outcomes according to gestational age at PPROM <28 weeks: a retrospective cohort study
First author · Under peer review · Division of Maternal-Fetal Medicine, Siriraj

Long-term continuation and predictors of levonorgestrel-releasing intrauterine system expulsion in women with benign gynecologic disorder
Co-author · Under editor review · Gynecologic Endocrinology Unit, Siriraj

Utilization of Albumin-Bilirubin score (ALBI Score) as a novel predictor for hepatocellular carcinoma in non-cirrhotic chronic hepatitis B carriers
First author · Under submission · Selected oral presentation, Siriraj Research Day 2025 · GI & Liver Center

Business Model for Holistic Rehabilitation: a PT B2B office syndrome solution
MSc Thesis, CMMU · Ongoing · Advisor: Assoc. Prof. Thanapon Weerasa

From Coxiella burnetii infection to pregnancy complications: key role of the immune response to placental cells
Research assistant · Published · IFMSA Exchange, Aix-Marseille Université, France

Awards & honours

🏅 รางวัล “สิ่งชูวงศ์ องอาจยุทธ และธีรพร เลิศรัฐ” — คลินิกอายุรศาสตร์ยอดเยี่ยมและมีจริยธรรม, Siriraj (2025)
🏅 Winner · MDCU Pitching Challenge (PodiPatch) · Grand Finalist · NUS Medical Grand Challenge · Winner · UniHack 2021 (UNITE)
🏅 Bronze Medal · International Physics Olympiad (IPhO 50), Tel Aviv (2019) · Bronze Medal · International Astronomy Olympiad (IAO XXII), Weihai (2017)
🏅 Gold Medal · Thailand Physics Olympiad (2018) · Gold Medal, 2nd place · Thailand Astronomy Olympiad (2017)

ญาณภัทร พินิจพิชิตกุล

ประวัติส่วนบุคคล — Personal Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล — Personal Information

- วันเกิด — 1 กรกฎาคม 2546 (อายุ 23 ปี)
- ที่อยู่ปัจจุบัน — กรุงเทพมหานคร
- โทรศัพท์มือถือ — 063-869-1888
- อีเมล — yanaphat1p@gmail.com
- งานอดิเรก — อ่านหนังสือ ลงทุน เปียโน ไวโอลิน ฟุตบอล วิ่ง ดูภาพยนตร์

ข้อมูลครอบครัว — Family Information

บิดา: นายสง่า พินิจพิชิตกุล
อาชีพ — แพทย์ (สูตินรีเวชวิทยา)

มารดา: นางพรรณสุนันท์ พินิจพิชิตกุล
อาชีพ — แม่บ้าน

ประวัติการศึกษา — Education History

สถาบัน	ระดับการศึกษา	หลักสูตร/ความสามารถพิเศษ	ปีที่จบ	GPAX
เซนต์คาเบรียล	ประถมศึกษา	-	2558	4.00
สวนกุหลาบวิทยาลัย	มัธยมต้น	GATE program	2561	3.99
เตรียมอุดมศึกษา	มัธยมปลาย	Gifted Math	2564	3.97
ศิริราชพยาบาล	อุดมศึกษา	แพทยศาสตรบัณฑิต โควต้าโอลิมปิกวิชาการ	2570	3.77
มหาวิทยาลัยมหิดล (MAP-C)	อุดมศึกษา	วิศวกรรมชีวการแพทย์	2571	3.60
วิทยาลัยการจัดการ มหิดล (CMMU)	อุดมศึกษา	การจัดการธุรกิจสุขภาพ (Pi-Shaped)	2571	3.83

- คะแนนภาษาอังกฤษ — TOEFL iBT 110/120 · TOEIC 985/990 · TOEFL ITP 637/667

ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ

- ดนตรี — เปียโน และไวโอลิน
- กีฬา — ฟุตบอล ว่ายน้ำ และวิ่งระยะไกล
- คอมพิวเตอร์ — Python, MySQL, Full-Stack Development, การวิเคราะห์ข้อมูล
- การผลิตสื่อ — ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ ออกแบบกราฟิก และงานนำเสนอ
- ภาษา — ไทย อังกฤษ (ดีมาก)

Awards & Signature Achievements

🏆 ชนะเลิศ / CHAMPION

🏆 ชนะเลิศ — MDCU Pitching Challenge · เงินรางวัล 30,000 บาท · 2025
PodiPatch — Co-Founder & Team Leader

🏆 ชนะเลิศ — UNIHACK 2021 Hackathon by Chula Tech Startup · 2021
UNITE — Founder & Team Leader

🌏 รางวัลระดับนานาชาติ / INTERNATIONAL

🌏 Grand Finalist — Medical Grand Challenge, NUS Singapore · 2024
PodiPatch — Co-Founder & Team Leader

🥉 เหรียญทองแดง — International Physics Olympiad 50th, Tel Aviv · 2019
🥉 เหรียญทองแดง — International Astronomy Olympiad XXII, Weihai · 2017
🎖️ Honorable Mention — Asian Physics Olympiad 20th, Adelaide · 2019

🥇 รางวัลระดับประเทศ / NATIONAL

🥇 เหรียญทอง — Thailand Physics Olympiad ครั้งที่ 17 · 2018
🥇 เหรียญทอง อันดับ 2 — Thailand Astronomy Olympiad ครั้งที่ 14 · 2017
⭐ Top 5 มหิดล — Startup Thailand League · ทุน NIA 25,000 บาท
Trawell — Founder & CEO

⭐ Grand Finalist — CU Case Discovery 2022 (20 ทีม จาก 200+ ทีม)

🩺 วิชาการและคลินิก / ACADEMIC & CLINICAL

🏆 รางวัล “สิ่งชูวงศ์ องอาจยุทธ และธีรพร เลิศรัฐ”
รางวัลนศพ. ชั้นปีที่ 5 ที่ได้คะแนนภาคปฏิบัติทางคลินิกวิชาอายุรศาสตร์ยอดเยี่ยม และมีจริยธรรม คุณธรรม สนใจผู้ป่วย เอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดี

🏆 คัดเลือก Oral Presentation — Siriraj Research Day
🏆 ALBI Score for HCC in non-cirrhotic chronic hepatitis B carriers · First author

⭐ รางวัลผลงานโดดเด่น — Clip VDO สอนฉีดอินซูลิน 3 ภาษา, รพ.สังขละบุรี · 2025

Overview (1/3) — Clinical Core / OB/GYN

1 · Research & Publications

- 👶 **First author** (Under Peer-review) — Maternal & Neonatal Outcomes according to gestational age at PPROM <28 wks: a retrospective cohort study · Division of MFM, Siriraj
- 🔬 **Co-author** (Under editor review) — Long-term continuation and predictors of levonorgestrel-releasing intrauterine system expulsion in women with benign gynecologic disorder: a retrospective cohort study · Gynecologic Endocrinology Unit, Siriraj
- 🏆 **First author** — Utilization of Albumin-Billirubin score (ALBI Score) as a novel Predictor for Hepatocellular carcinoma Prediction in Non-Cirrhotic Chronic Hepatits B Carriers: a retrospective cohort study · GI & Liver Center, Siriraj — คัดเลือก Oral Presentation, Siriraj Research Day
- 📈 **Ongoing Thesis (CMMU)** — Business model for holistic rehabilitation and PT B2B office syndrome solution · อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ธนพล วีราสา
- 👨‍🔬 **Research assistant Elective** — From Coxiella burnettii Infection to Pregnancy complications: Key role of the immune response to Placental Cells

2 · Leadership — SIOGC (Siriraj Obstetrics & Gynecology Club)

- **ประธาน (President) และผู้ก่อตั้ง (Founder)**, Siriraj Obstetrics and Gynecology Club · มิ.ย. 2024–ปัจจุบัน
- ผู้ก่อตั้งหน่วยวิจัยนักศึกษาแพทย์ด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (OB/GYN Student Research Club Unit)
- SIOGC First Meet 2025 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม
- SIOGC Workshop (4 สถานี) 2025 — ประธานควบคุมดูแลการจัดบูธกิจกรรม
- HPV Self-Test Community Project ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2025 — ควบคุมดูแลและออกแบบการจัดกิจกรรม
- Resident Playbook Movie Night 2025 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม
- แคมเปญเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2025 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม
- กิจกรรม LGBTQ+ Awareness 2025 · Pride Month Movie Night 2025 — ประธานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม
- Siriraj Open House Booth 2025 · งานเบิกฟ้าชมรม 2025 — ประธานควบคุมดูแลการจัดบูธ

3 · Clinical Electives & Conferences — OBGYN & Others

- **Clinical Exchange (OB/GYN, pending), Duke University, USA** · 5-30 เม.ย. 2027 — ได้รับเลือกเป็นตัวแทนศิริราช
- Clinical Exchange, Orthopedic & Plastic Surgery, NUH, NUS สิงคโปร์ · 24 ก.พ.-21 มี.ค. 2025
- OB/GYN Elective — คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล · 16-27 มี.ค. 2026
- OB/GYN Elective — มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ · 2-13 มี.ค. 2026
- OB/GYN Elective — มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ · 30 มี.ค.-10 เม.ย. 2026
- OB/GYN Elective — ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก · 18-30 ต.ค. 2026
- Observer, ตัวแทน SIORS ในงาน 46th RCOST Annual Meeting · 17-19 ต.ค. 2024
- 33rd Congress of the Thai Society for Reproductive Medicine (TSRM) · 9-12 มี.ค. 2026
- เข้าร่วมสัมมนา RTCOG ทาง Zoom— Infertility Management (22 ส.ค. 2026) · Cesarean Scar Defect (25 ก.ค. 2026) · Reproductive Medicine Conference ครั้งที่ 22 (30 ต.ค. 2025)
- **สำเร็จหลักสูตร Obstetrics & Gynecology for General Practitioners, CMU E-learning มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

Overview (2/3) — Beyond the Ward

4 · Innovation & Entrepreneurship

- **PODIPATCH — Co-Founder & Team Leader** · microneedle พร้อม integrated wound care สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
- **TRAWELL — Founder & CEO (เม.ย. 2021–ปัจจุบัน)** · Health Travel Tech Startup ระยะ Ideation
- **UNITE — Founder & Team Leader (ม.ค. 2020 – พ.ค. 2023)** · Edtech Startup ระยะ Prototype, Full-stack developer
- Business & Product Design Internship, NIRVAMED (พ.ค. 2024–ปัจจุบัน) · Lean Management + Catheter / contrast removal system
- Back-End Developer Internship, MonkeyEveryday Co., Ltd. (ม.ค.–มิ.ย. 2020) · MySQL, Learning Behavior Tracking
- 42 Bangkok Cadet (มิ.ย. 2021 – มิ.ย. 2026) · 1 ใน 120 คนแรกที่ผ่าน Piscine จากผู้สมัครกว่า 10,000 คน
- Medcubator 2022 Pre-Incubation Program by TMSIC · MSEC II 2022 Incubation Program by Mahidol Startup Club
- Finance Team, Thai Medical Student Innovation Club (TMSIC) · 2022
- **รองอุปนายกพัฒนาบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยี, สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช · 2024**
- **หัวหน้าทีม Startup อุปนายกพัฒนาบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช · 2022**
- ประธานจัดงาน Road to MedTech Career Path Conference (ต.ค. 2024) · MC งาน Research x Startup Talk by SMSU (16 ก.ค. 2022) · Head of Facilitator, Siriraj-RISE Hackathon (23-24 ก.ค. 2022)

5 · Global Health & Public Health

- **รองประธาน (VP) และผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder), Siriraj Global Health Club · 2023–2025**
- Observer, PMAC 2025 "Harnessing Technology in an Age of AI" · PMAC 2026 "Youth for Equitable Health in a Changing Demographic World"
- **รองประธาน PMAC Global Health Case Competition** · 2025, 2026 (PMAC side-event)
  ศึกษาดูงาน BDMS — PMAC Field Trip "Exploring AI Healthcare Ecosystem in Thailand" · 30 ม.ค. 2025
- ผู้ก่อตั้ง Siriraj Global Health Case Competition Unit
- ประธานคัดเลือกตัวแทนมหิดล & เข้าร่วม Indo-Pacific Global Health Case Competition, Univ. of Melbourne · 2024, 2025
- กรรมการ CURASI Global Health Capacity Building (CU x RA x SI) · 5 ต.ค. & 9 พ.ย. 2024
- ผู้ริเริ่มโครงการ Health Management Elective, Global Health Elective Unit
- **Global Health & Management Elective — กับนายแพทย์ สสจ.พิจิตร · 9-22 ก.พ. 2025**
- ศึกษาดูงาน BDMS — PMAC Field Trip "Exploring AI Healthcare Ecosystem in Thailand" · 30 ม.ค. 2025

Overview (3/3) — Beyond the Ward

6 · International Exchange & Olympiads

• ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ Siriraj **ไปแลกเปลี่ยน OB/GYN ที่ Duke University**, เม.ย. 2027
• Public Health Internship (HPV vaccination ลาว), Saw Swee Hock School of Public Health, NUS · 21 ก.พ.-7 มี.ค. 2024 — Assoc. Prof. Kiesha Prem
• ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ Siriraj แลกเปลี่ยน **Orthopedics, Plastic surgery ที่ NUH, NUS, Singapore** มี.ค.- เม.ย.2024
• IFMSA SCORE Funded, **Research Exchange Program, Aix-Marseille Université, ฝรั่งเศส · 1 เม.ย.-10 พ.ค. 2023**
• SCORE Local Exchange Selection Team, IFMSA · 2023
• ตัวแทนประเทศไทย — **International Physics Olympiad 50 · International Astronomy Olympiad XXII · Asian Physics Olympiad 20 (2017–2019)**

7 · Community Service & Volunteer

• ผู้ริเริ่มและกรรมการ Issara Project — Hypertension Screening ชุมชนคลองเตย · 2025
• หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ — ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านดอนยาง สังขละบุรี · 2025
• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนกองม่องทะ — สังขละบุรี · 2025
• คลิปสอนฉีดอินซูลิน 3 ภาษา — รพ.สังขละบุรี · 2025 (รางวัลผลงานโดดเด่น)
• คณะผู้จัดทำ VDO ส่งเสริม HPV Screening ร่วมกับ อ.ปนิชา · 2025
• ร่วมรณรงค์หยุดเผาป่า ลดฝุ่นควัน — ท่าพ่อ พิจิตร · 2025
• พูดสร้างแรงบันดาลใจเรื่องการศึกษา — รร.บ้านท่าพ่อ พิจิตร · 2025
• อาสาสมัครสอน CPR/BLS — โครงการ "CPR ปั๊มเหอะพี่ขอ" · 2025

8 · Other activities

• เลขานุการ คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 4 · 2024-2025
• ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 2 · 2022-2023
• สมาชิกทำงานฝ่ายกิจกรรม Nice to Meet (Sala)ya 2022
• สมาชิกทำงานฝ่ายกิจกรรม Siriraj Family Concert 2023 ·
•สมาชิกทำงานฝ่ายกิจกรรม รับน้องข้ามฟาก 2023

เหตุผลในการเลือกเรียนต่อสูติ-นรีเวช

Extern ญาณภัทร พินิจพิชิตกุล — คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆ คุณพ่อซึ่งเป็นแพทย์นรีเวชผ่าตัดผ่านกล้อง มักพาผมไปสังเกตการณ์เคสทั้งใน OR, OPD และห้องฉุกเฉิน โดยเฉพาะเคสฉุกเฉินอย่าง ruptured ectopic pregnancy หรือ placental abruption ที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายในเวลาเดียวกัน ภาพที่ติดตาผมไม่ใช่แค่การรักษาคนไข้ แต่คือความเป็นเหตุเป็นผลของกลไกร่างกาย ตั้งแต่ physiology ของฮอร์โมนไปจนถึง mechanism of labor ที่มีความเป็น physics สูง สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมหลงใหลในห้องผ่าตัดและมั่นใจตั้งแต่เนิ่นๆ ว่า**สูติ-นรีเวชคือสาขาที่จะเป็นชีวิตของผมต่อจากนี้**

แต่ยิ่งเรียนคลินิกมากขึ้น ผมยิ่งเห็นช่องว่างหนึ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คือประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ ผมเองมีโอกาสได้เห็นนวัตกรรมหลายอย่างด้วยตาตัวเอง ทั้งเทคนิคผ่าตัดอย่าง V-NOTES การใช้ Indocyanine Green ระบุตำแหน่งท่อไตเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และแนวคิดอุปกรณ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบพกพาที่ผสาน AI แม้เทคโนโลยีเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในระดับโลก แต่**อัตรา adoption จริงในระบบสูติ-นรีเวชของไทยยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาก** แน่นอนว่าช่องว่างนี้ไม่ได้มีสาเหตุจากการขาดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากกับปัจจัยที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก ทั้งงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อ และกำลังคนที่จำกัด สิ่งที่แพทย์รุ่นใหม่คนหนึ่งอย่างผมพอทำได้ อาจไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งระบบในคราวเดียว แต่คือการ**เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยผลักดันแนวคิดและทดลองสิ่งใหม่ในขอบเขตที่ทำได้จริง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากอาจารย์และรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์**ในระบบมากกว่าผมมาก

ด้วยความเชื่อนี้ ผมจึงตั้งใจสร้างฐานความรู้สามด้านไปพร้อมกัน คือคลินิก วิศวกรรมชีวการแพทย์ (MAP-C มหาวิทยาลัยมหิดล) และการจัดการธุรกิจสุขภาพ (Pi-Shaped, CMMU) เพราะเชื่อว่าการทำให้นวัตกรรมถูกใช้จริงไม่ได้ต้องการแค่ไอเดีย แต่ต้องเข้าใจทั้งวิศวกรรมและกลไกที่จะพามันไปถึงคนไข้ ความเชื่อนี้ทำให้ผมตั้งใจที่จะพิสูจน์ผ่านการลงมือทำ ผมร่วมก่อตั้งและเป็นหัวหน้าทีม Podipatch อุปกรณ์ microneedle ดูแลแผลเบาหวานที่เท้า ตั้งแต่ออกแบบจนเข้ารอบ Grand Finalist ที่ NUS Medical Grand Challenge และได้รางวัลชนะเลิศ MDCU Pitching Challenge พร้อมฝึกงาน Product Design จริงกับ Nirvamed สตาร์ทอัพด้านสายสวนหัวใจ

แม้จะมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่หัวใจสำคัญที่สุดของผมยังคงเป็นงานคลินิก ตลอดการเรียนแพทย์ชั้นคลินิก ผมได้ผ่านการปฏิบัติงานในทุกๆสาขาวิชา ที่ต้องรับมือกับเคสหนักและตัดสินใจภายใต้ความกดดันอยู่เสมอ **ผมได้มีโอกาสรับรางวัล“สิ่งชูวงศ์ องอาจยุทธ และธีรพร เลิศรัฐ” รางวัลที่จะมอบให้**
นศพ. ชั้นปีที่ 5 ที่ปฏิบัติงานทางคลินิกวิชาอายุรศาสตร์ยอดเยี่ยม และมีจริยธรรม คุณธรรม สนใจผู้ป่วย และเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดี รวมทั้งยังเคยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีดูแลผู้ป่วยที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านดอนยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ทำให้คุ้นเคยกับจังหวะงานเวร ความกดดัน และความรับผิดชอบของงานคลินิกในบริบทที่หลากหลาย ผมยังได้มีโอกาสเห็นคุณพ่อตรวจติดตามคนไข้จนเกิดความผูกพัน มีคนไข้แวะเวียนมาเยี่ยมด้วยความขอบคุณ ผมจึงยิ่งมั่นใจว่า**งานตรวจและรักษาคนไข้คือสิ่งที่ผมอยากทำไปตลอดชีวิต** นวัตกรรมสำหรับผมจึงเป็นเครื่องมือที่ต่อยอดจากงานคลินิก ไม่ใช่สิ่งที่มาแทนทีมัน

เหตุผลในการเลือกเรียนต่อสูติ-นรีเวช

ขณะเดียวกัน การเป็นผู้ก่อตั้งและประธานชมรม SIOGC ทำให้ผมได้ทำงานใกล้ชิดกับทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์แพทย์ในภาควิชา และเห็นว่าบุคลากรในสาขานี้มีไฟ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นจากนักศึกษาและแพทย์รุ่นใหม่อยู่เสมอ นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจว่าสูติ-นรีเวชเป็นพื้นที่ที่แพทย์รุ่นใหม่อย่างผมสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้จริง ไม่ใช่แค่ในทางทฤษฎี ผมจึงพยายามหาโอกาสออกไปเรียนรู้จากภายนอกอย่างจริงจัง ตั้งแต่การเดินเข้าไปนำเสนอไอเดียและความสนใจกับ Assoc. Prof. Kiesha Prem หลังฟังบรรยายที่ PMAC จนได้ฝึกงานวิจัยที่ NUS Saw Swee Hock School of Public Health เรื่องวัคซีน HPV ในลาว ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนวิจัยกับ IFMSA ที่ Marseille และล่าสุดคือการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศิริราชไป Clinical Exchange ด้าน OB/GYN ที่ Duke University เดือนเมษายน 2570 — ทุกครั้งที่ออกไป ผมไม่ได้ไปเพื่อสะสมประสบการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ไปเพื่อต้องการสำรวจว่าขณะนี้โลกไปถึงไหน แล้วนำกลับมาปรับใช้กับบริบทไทย

Research & Publications

4 + 1
Research Projects

3
Departments Involved

1
Oral Presentation Selected

Key Research Highlights

1. First Author — Maternal & Neonatal Outcomes according to gestational age at PPROM <28 wks: a retrospective cohort study

Under **Peer review** · Division of Maternal-Fetal Medicine, Siriraj

*Authors: **Yanaphat Pinijpichitkul**, Chonrasit Chinvarakorn, Irene Siriadun (co-first authors); Saifon Chawanpaiboon, MD (corresponding author)*

Role: ร่วมคิดคำถามการวิจัย ออกแบบกรอบเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียน วิเคราะห์ทางสถิติ และเขียนต้นฉบับบทความในฐานะผู้นิพนธ์หลัก

2. Co-Author — Long-term continuation and predictors of levonorgestrel-releasing intrauterine system expulsion in women with benign gynecologic disorder: a retrospective cohort study

Under **editor review** · Gynecologic Endocrinology Unit, Siriraj

*Authors: Matus Phunyammalee, MD; **Yanaphat Pinijpichitkul**; Thanyarat Wongwananuruk, MD; Panicha Chantrapanichkul, MD; Pavarit Humart, MD; Prasong Tanmahasamut, MD (corresponding author)*

Role: ร่วมเก็บข้อมูลผู้ป่วยและสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติร่วมกับทีมวิจัยหลัก

3. First Author — Utilization of Albumin-Billirubin score (ALBI Score) as a novel Predictor for Hepatocellular carcinoma Prediction in Non-Cirrhotic Chronic Hepatits B Carriers: a retrospective cohort study

Under submission, **Selected Oral Presentation, Siriraj Research Day 2025** · GI & Liver Center

*Authors: **Yanaphat Pinijpichitkul,** Prarb Sirivatanauksorn; Supot Nimanong, MD (corresponding author)*

Role: คิดคำถามการวิจัย ออกแบบการเก็บข้อมูลย้อนหลัง เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย

4. MSc Thesis (CMMU) — Business Model for Holistic Rehabilitation

Ongoing · PT B2B Office Syndrome Solution
*Authors: **Yanaphat Pinijpichitkul,** Thanapol Virasa*

Role: ออกแบบโมเดลธุรกิจ วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง และพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับโซลูชันฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม

5. Reseach Assistant, Exchange Program — From Coxiella burnettii Infection to Pregnancy complications: Key role of the immune response to Placental Cells

Published, **Research assistant elective**
Authors: Sandra Madariaga Zarza, Soraya Mezouar, Jean-Louis Mege

Role: ศึกษาดูงาน Research ที่ฝรั่งเศษ ทำ Cell culture, PCR, Prepare specimen for Electron Microscope

Research Abstracts (1/2)

1. Maternal and neonatal outcomes according to gestational age at preterm prelabour rupture of membranes before 28 weeks: a retrospective cohort study

Yanaphat Pinijpichitkul*, Chonrasit Chinvarakorn*, Irene Siriadun* (co-first authors); Saifon Chawanpaiboon, MD (corresponding author)
Division of Maternal-Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University · Under peer review

Background — Preterm prelabour rupture of membranes (PPROM) before 28 weeks of gestation is uncommon but carries substantial maternal and neonatal risk, and its management remains controversial. This study evaluated maternal and neonatal outcomes in these pregnancies and identified factors associated with prolonged latency.

Methods — Retrospective cohort of women with singleton pregnancies complicated by PPROM before 28 weeks who delivered at Siriraj Hospital between January 2012 and December 2024, categorised into three groups by gestational age at rupture (<24, 24+0–25+6 and 26+0–27+6 weeks). Multivariable Firth penalised logistic regression identified factors associated with prolonged latency (>48 hours).

Results — Seventy-seven pregnancies were included (9, 30 and 38 per group). Maternal complications — clinical chorioamnionitis, placental abruption and cord prolapse — were comparable between the 24+0–25+6 and 26+0–27+6 groups, as were major neonatal morbidities. Surviving neonates in the 24+0–25+6 group had a longer median hospital stay (108.5 vs 85.0 days; P = 0.042). Completion of at least one course of antenatal dexamethasone was independently associated with prolonged latency (OR 17.23; 95% CI 5.02–76.25; P < 0.001).

Conclusions — Maternal complications and major neonatal morbidities were comparable between gestational-age groups. Earlier PPROM was associated with prolonged neonatal hospitalisation, whereas completion of antenatal corticosteroid therapy was strongly associated with prolonged latency, likely reflecting successful expectant management.

2. Long-term continuation and predictors of levonorgestrel-releasing intrauterine system expulsion in women with benign gynecologic disorders: a retrospective cohort study

Matus Phunyammalee, MD; Yanaphat Pinijpichitkul; Suchada Indhavivadhana, MD; Thanyarat Wongwananuruk, MD; Manee Rattanachaiyanont, MD; Panicha Chantrapanichkul, MD; Pavarit Humart, MD; Prasong Tanmahasamut, MD (corresponding author)
Gynecologic Endocrinology Unit, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University · Under editor review

Background — The levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS) is a highly effective non-surgical treatment for benign gynecologic disorders, but spontaneous expulsion remains a primary cause of treatment failure. This study evaluated long-term cumulative continuation rates and identified independent risk factors for device expulsion.

Methods — Retrospective cohort at the Faculty of Medicine Siriraj Hospital including women who underwent LNG-IUS insertion for benign gynecologic disorders (adenomyosis, heavy menstrual bleeding, uterine leiomyoma) between January 2005 and September 2025. Cumulative continuation was estimated by Kaplan-Meier analysis; age, BMI, history of vaginal delivery, uterine cavity length and primary indication were analysed with a Cox proportional-hazards model.

Results — 261 patients were included, median follow-up 35.6 months. Indications were adenomyosis (66.7%), non-structural causes (20%), pelvic endometriosis (6.8%) and uterine leiomyoma (6.5%). Cumulative continuation was 87.1% (95% CI 83.0–91.2) at 12 months and 80.7% (95% CI 75.4–86.0) at 60 months. Primary clinical indication independently predicted expulsion (P < 0.01): versus non-structural causes, hazards were higher for uterine leiomyoma (aHR 11.03; 95% CI 2.63–46.31) and adenomyosis (aHR 3.65; 95% CI 1.05–12.71).

Conclusions — LNG-IUS continuation is a dynamic, time-dependent outcome. Most expulsions occur within the first year after insertion, whereas women who retain the device beyond that point have a high probability of sustained long-term treatment — information directly relevant to counselling and individualised follow-up.

Research Abstracts (2/2)

3. Utilization of Albumin-Bilirubin score (ALBI Score) as a novel predictor for hepatocellular carcinoma in non-cirrhotic chronic hepatitis B carriers

Yanaphat Pinijpichitkul; Prarb Sirivatanauksorn; Supot Nimanong, MD (corresponding author) · Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Under submission · Selected Oral Presentation, Siriraj Research Day 2025 · GI & Liver Center

Objectives — To assess the utility of the albumin-bilirubin (ALBI) score in predicting hepatocellular carcinoma (HCC) in non-cirrhotic chronic hepatitis B patients, and to establish and validate a reliable ALBI cut-off as a poor prognostic factor.

Methods — Retrospective cohort of non-cirrhotic hepatitis B carriers with and without HCC followed at the Siriraj Hepatitis Clinic between 2007 and 2014. Of 123 subjects, 52 were excluded for insufficient bilirubin documentation, leaving 71. HCC was the primary outcome. Univariable and multivariable Cox models were fitted; the cut-off was determined by maximum concordance index (C-index).

Results — Among 71 patients, 64 were non-HCC and 7 developed HCC over a median follow-up of 16.02 years. Univariable analysis gave an HR of 16.23 (95% CI 0.70–378.15). After adjustment for ALT, platelet count, age, sex and HBV viral load, ALBI lost significance (HR 0.18), but removing ALT restored it as an independent factor (HR 3.15), suggesting correlation between ALBI and ALT. The optimal cut-off of −3.027 gave the highest C-index (0.686), close to the median ALBI of −3.05 (SD 0.25).

Conclusions — This cut-off may improve early risk stratification in non-cirrhotic carriers. The model showed instability in multivariable analysis owing to small sample size and low event rate, warranting validation in larger datasets.

4. Business Model for Holistic Rehabilitation: a PT B2B office syndrome solution

Yanaphat Pinijpichitkul · MSc Thesis, College of Management, Mahidol University (CMMU) · Advisor: Assoc. Prof. Thanapon Weerasa
Ongoing — abstract to be added on completion

Scope — Designing a business model for a holistic rehabilitation service, with market and competitor analysis and a business plan for a physiotherapist-led B2B office syndrome solution. Data collection and write-up are in progress.

5. From Coxiella burnetii infection to pregnancy complications: key role of the immune response to placental cells

Sandra Madariaga Zarza, Soraya Mezouar, Jean-Louis Mege · Aix-Marseille Université, France
Published · Research assistant, IFMSA research exchange elective

Abstract — Infection of pregnant animals and women by Coxiella burnetii, an intracellular bacterium, compromises both maternal health and foetal development. The placenta is targeted by C. burnetii, as shown by bacteriological and histological evidence, and placental strains appear highly virulent compared with reference strains. Trophoblasts, the major placental cells, are largely infected and may represent a replicating niche for the bacteria. The placenta also contains numerous immune cells: placental macrophages are infected and activated in an unusual M1 polarisation associated with bacterial elimination, and placental mast cells eliminate bacteria by releasing extracellular actin filaments and antimicrobial peptides, whereas C. burnetii impairs maturation of decidual dendritic cells, favouring bacterial pathogenicity. This review examines C. burnetii infection of human placentas, with attention to the action and function of the different immune cells and trophoblasts targeted in relation to foetal injury.

Role — Laboratory work during the exchange: cell culture, PCR, and specimen preparation for electron microscopy.

Leadership — SIOGC President & Founder

Overview

2024 (ชั้นปีที่ 4)

ก่อตั้งชมรม SIOGC และเริ่มวางแผนกิจกรรมแรกของชมรม

2025 (ชั้นปีที่ 5)

จัดกิจกรรม 10 รายการ ครอบคลุมงานวิชาการ หัตถการ และงานชุมชน มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน



10
Initiatives Led

500+
Participants Reached

2024–ปัจจุบัน
Tenure

ตอนเด็กๆ คุณพ่อมักพาผมไปสังเกตการณ์เคสทั้งใน OR และห้องฉุกเฉิน สิ่งที่ทำให้ผมหลงใหลไม่ใช่แค่การรักษาคนไข้ แต่คือการได้เห็นว่าสูติ-นรีเวชเป็นสาขาที่ต้องคิดเร็วและตัดสินใจแม่นยำภายใต้ความกดดันตลอดเวลา แต่เมื่อขึ้นชั้นคลินิกจริง ผมกลับพบว่าศิริราชยังไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์ที่สนใจสาขานี้มารวมตัวกัน แลกเปลี่ยนความรู้ หรือรู้จักอาจารย์ในภาควิชานอกเหนือจากตอนขึ้นวอร์ด ผมจึงชวนเพื่อนๆ น้องๆ ที่สนใจมาก่อตั้งชมรม SIOGC ขึ้นมาในฐานะ Founder และประธานคนแรก โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากให้น้องๆ ทั้ง Preclinic และ Clinic ที่ยังหาตัวเองไม่เจอได้เข้าใจศาสตร์ของสูติ-นรีเวชมากขึ้น ก่อนที่จะต้องตัดสินใจเลือกสาขาจริง

Key Initiatives as President

- **1. SIOGC First Meet (2025)**
  งานเปิดตัวชมรมครั้งแรก เชิญแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวชมาพูดคุยแรงบันดาลใจและเส้นทางสู่สาขา
- **2. SIOGC Workshop — 1st Workshop (2025)**
  เวิร์กช็อปหัตถการพื้นฐาน OB/GYN 4 สถานี เปิดให้รุ่นน้องฝึกหัตถการจริงบนหุ่นจำลอง
- **3. Siriraj Open House Booth (2025)**
  ออกแบบและควบคุมดูแลบูธกิจกรรมของชมรมในงาน Siriraj Open House เพื่อแนะนำสาขาให้รุ่นน้อง
- **4. เบิกฟ้าชมรม Booth (2025)**
  จัดบูธแนะนำชมรมในงานเบิกฟ้าชมรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่
- **5. Resident Playbook Movie Night (2025)**
  จัดกิจกรรมแนะแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์ประจำบ้านผ่านภาพยนตร์และการพูดคุย
- **6. Annual Conference Campaign (2025)**
  จัดแคมเปญเชิญชวนนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย
- **7. LGBTQ+ Awareness Activities**
  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ในบริบททางการแพทย์
- **8. Pride Month Movie Night (2025)**
  จัดกิจกรรมให้ความรู้และฉายภาพยนตร์เนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ
- **9. HPV Self-Test Community Project (2025)**
  ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง HPV ในชุมชน
- **10. Founder, OBGYN Student Research Club Unit (2025)**

SIOGC — จุดเริ่มต้นของชมรม

President & Founder — ก่อตั้งและวางระบบชมรมตั้งแต่ศูนย์ (2024–ปัจจุบัน)



ผมชวนเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ที่สนใจสูติ-นรีเวชเหมือนกันมาคุยกันก่อนว่าอยากทำแบบนี้ไหม พอทุกคนเห็นด้วย ผมก็เริ่มวางโครงสร้างชมรมทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์ ทั้ง vision, mission กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า**อยากให้น้องๆ ได้สัมผัสกับสาขานี้ตั้งแต่ Preclinic, Clinic ก่อนจะต้องตัดสินใจเลือกเรียนสาขาจริง** และสร้างชุมชนของคนที่รักสูติ-นรีเวชเช่นเดียวกัน เปิดโอกาสให้ได้รู้จักกับอาจารย์ และเปิดโอกาสทางวิชาการจากนั้นแบ่งทีมงานเป็น 8 ฝ่าย วาง workflow ที่ชัดเจนตั้งแต่ initiate event ไปจนถึง final evaluation และวางระบบ hierarchy ของคณะกรรมการให้ชัดเจนตั้งแต่วันแรก

ส่วนที่ยากที่สุดไม่ใช่การคิดไอเดียกิจกรรม **แต่คือการออกแบบระบบให้ชมรมอยู่ได้ต่อแม้ไม่มีผมแล้ว** ต้องคิดเรื่อง succession plan และความยั่งยืนทางการเงินตั้งแต่วันแรก

สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจทำตั้งแต่ต้นคือให้ SIOGC เป็นพื้นที่เปิดกว้างจริงๆ ไม่ใช่แค่วิชาการ เลยตั้งฝ่าย LGBTQ+ ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจัด Pride month และโปรโมท SI-pride clinic เพราะอยากลบภาพจำว่าศิริราช conservative

ปีแรกของชมรม (2024–2025) มีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ First Meet เปิดตัวชมรม ไปจนถึง Workshop หัตถการพื้นฐาน พานักศึกษาเข้าดูงานใน OR จริง กิจกรรม Pride month และปิดท้ายด้วยงานวิชาการที่เชิญวิทยากรต่างประเทศ แต่ละงานเป็นตัวต่อแต่ละชิ้น ที่ต่อกันจนสร้างมาเป็นชมรม สร้างกลุ่มคนที่รักในสิ่งเดียวกัน สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ ให้รุ่นน้อง ไม่ใช่แค่ไอเดียในหัวของผม นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุด

My takeaway

การก่อตั้งชมรมสอนผมเรื่อง systems thinking ไม่ใช่แค่จัดงานให้สนุก แต่ต้องออกแบบให้ระบบเดินต่อไปได้เองในระยะยาว
และที่สำคัญ**ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นสูตินรีแพทย์ ทั้งจากพี่ๆแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ ทำให้มั่นใจว่าอยากจะเป็นสูตินรีแพทย์ที่ดีให้ได้**

Leadership — SIOGC President & Founder






SIOGC First Meet — งานเปิดตัวของชมรม (2025)

- งานเปิดตัวชมรม SIOGC ครั้งแรก เชิญแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวชมาพูดคุยเรื่องแรงบันดาลใจและเส้นทางสู่สาขา OB/GYN
- เป็นประธานและผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วางคอนเซปต์งานจนถึงประสานงานกับวิทยากร
- เป้าหมายคือให้รุ่นน้องได้สัมผัสและรู้จักสาขา OB/GYN ตั้งแต่ชั้นปีต้น ก่อนต้องตัดสินใจเลือกสาขา







Siriraj Open House — 3 Clinical Skills Workshops (2025)

- ออกแบบและควบคุมดูแลบูธกิจกรรม 3 สถานี: Normal Labor, IUD/ICD insertion และ PV & Pap smear
- ให้น้องนักศึกษาแพทย์และผู้เข้าชมงานได้ลองฝึกหัตถการพื้นฐานทาง OB/GYN บนหุ่นจำลอง
- เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของชมรมที่ทำต่อเนื่องเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสาขานี้ให้กว้างขึ้นในหมู่นักศึกษาแพทย์





Resident Playbook Movie Night (2025)

- กิจกรรมภาพยนตร์เชิงโต้ตอบ สอดแทรกความรู้ระดับ high-yield สำหรับเตรียมสอบ
- ออกแบบเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับเคสจริงในสูติ-นรีเวชที่พบบ่อย
- จัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้รุ่นน้องก่อนช่วงสอบและก่อนขึ้นวอร์ด

Leadership — SIOGC President & Founder



HPV Self-Test Community Project (2025)

- ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง HPV ในชุมชน
- ให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง (HPV self-test)
- ขยายการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองไปยังกลุ่มที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยาก



Pride Month Movie Night (2025)

- ฉายภาพยนตร์ Heartstopper พร้อมเซสชันพูดคุยเรื่อง hormonal therapy และประเด็นสุขภาพ LGBTQ+
- สร้างพื้นที่เปิดกว้างให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจมิติสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้น

Leadership — SIOGC President & Founder



1st SIOGC Workshop (2025)

• เวิร์กช็อปหัตถการพื้นฐาน OB/GYN 4 สถานี: Normal Labor, Perineorrhaphy, Contraceptives & IUD insertion, PV & Pap smear
• เปิดให้รุ่นน้องนักศึกษาแพทย์ฝึกหัตถการจริงบนหุ่นจำลองภายใต้การดูแลของวิทยากร
• เป็นเวิร์กช็อปแรกที่ชมรมจัดขึ้นเอง วางรากฐานให้กิจกรรมเชิงหัตถการต่อเนื่องในปีถัดมา

กิจกรรมอื่น ๆ ที่ริเริ่มในฐานะประธานชมรม

เบิกฟ้าชมรม Booth (2025)
จัดบูธแนะนำชมรมและกิจกรรมให้นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่

Annual Conference Campaign (2025)
ชวนนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยสูตินรีเวชฯ

LGBTQ+ Awareness Activities
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ในบริบททางการแพทย์

OB/GYN Student Research Club Unit
ก่อตั้งหน่วยงานวิจัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ภายใต้ชมรม SIOGC

Conferences & Symposium



Observer, 33rd Congress of the Thai Society for Reproductive Medicine (TSRM), 2026



Observer, SIGEM Conference, 2026



Observer, SIORS representatives, 46th RCOST Annual Meeting, 2024

Additional Courses & Seminars

CMU E-learning — OB/GYN for General practitioner
สำเร็จหลักสูตรออนไลน์ด้านสูติ-นรีเวชสำหรับแพทย์ทั่วไป

สัมมนา Infertility Management (RTCOG)
Clinical Updates and Evidence-Based Practice · 22 ส.ค. 2026

สัมมนา Cesarean Scar Defect (RTCOG)
More Than a Scar: Understanding Cesarean Scar Defect · 22 ส.ค. 2026

สัมมนา Reproductive Medicine ครั้งที่ 22
จัดโดย RTCOG · 30 ต.ค. 2025

Innovation & Entrepreneurship

Overview

2020

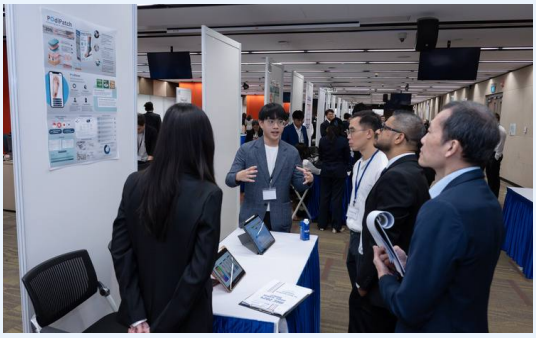
ก่อตั้ง UNITE (Edtech Startup) และเข้าร่วม 42 Bangkok Cadet

2021–2025

ก่อตั้ง Trawell และพัฒนา Podipatch สู่รอบ Grand Finalist ระดับนานาชาติ (2021–2025)

2024–2025

Internship ที่ Nirvamed



3
Medical Innovation Startups Founded

2
Grand Finalist Titles

2025
MDCU Pitching Challenge Winner

ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสุขภาพสูงมาก แต่ช่องว่างระหว่างการมีเทคโนโลยีกับการนำไปใช้จริงในระบบสุขภาพยังกว้างอยู่ Podipatch, UNITE และ Trawell คือพื้นที่ที่ผมใช้ฝึกฝนการมองปัญหาแบบผู้ประกอบการ ตั้งแต่การตั้งโจทย์ พัฒนาต้นแบบ ไปจนถึงการนำเสนอต่อกรรมการและนักลงทุนจริง ประสบการณ์เหล่านี้สอนให้ผมเข้าใจว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และความสามารถลงมือทำจริง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผมอยากนำมาต่อยอดในงานสูตินรีเวชต่อไป

Key Ventures

- **Podipatch — Co-founder & Team Lead**
  อุปกรณ์ microneedle ดูแลแผลเบาหวานที่เท้า เข้ารอบ Grand Finalist NUS Medical Grand Challenge 2024 และชนะเลิศ MDCU Pitching Challenge 2025

- **UNITE — Founder & Team Lead**
  Edtech Startup ระยะ Prototype รับผิดชอบการบริหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ Full-stack Development

- **Trawell — Founder & CEO**
  Health Travel Tech Startup ระยะ Ideation ได้รับทุน 25,000 บาท จาก Startup Thailand League

- **Nirvamed — Business & Product Design Intern**
  ออกแบบระบบ Lean Management และทดลอง Product Development กับสตาร์ทอัพด้านสายสวนหัวใจ

CHAPTER · INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP

FROM PATIENT TO PRODUCT

PodiPatch · Co-Founder & Team Lead · 2023–2025

ตอนขึ้นวอร์ดปี 4 ผมเจอผู้ป่วยแผลเรื้อรังจากเบาหวานจำนวนมาก หลายรายลงเอยที่การตัดขา ผมพบว่าปัญหาหลักคือ Compliance ในการดูแลรักษาแผล และควบคุมโรคเบาหวาน สิ่งที่ติดอยู่ในหัวตอนนั้นไม่ใช่เรื่องวิธีการรักษา เนื่องจากวิธีการรักษาควบคุมดูแลเบาหวานก็เป็นความรู้ที่สอนผู้ป่วยตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ Technology ต่างหากที่จะช่วยให้ Compliance ของผู้ป่วยดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเข้าใจบริบท Holistic care ของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

ผมได้นึกถึงค่าย Medcubator ปี 1–2 ที่ได้เจออาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ จุฬาฯ ซึ่งทำวิจัย microneedle เทคโนโลยีที่ตอนนั้นใช้กันแค่ในวงการ skincare ผมเห็นว่าถ้าเอามาใช้กับแผลเรื้อรังได้ มันจะแก้ปัญหา compliance ที่ต้นเหตุ เพราะแผ่นแปะทำงานเองโดยผู้ป่วยไม่ต้องจำอะไรเลย

ความรู้คลินิกที่เห็นปัญหาคนไข้จริง เมื่อมีร่วมกับกับพื้นฐาน Biomedical engineering และ Interpersonal skills คือสิ่งที่ทำให้ PodiPatch สำเร็จขึ้นมาได้

ในฐานะ Co-founder และ Team Lead ผมนำทีมเข้าปรึกษาอาจารย์เพื่อทำ feasibility analysis ออกแบบให้เซนเซอร์ไมโครนีเดิลวัดระดับการอักเสบของแผล แล้วศึกษาความเป็นไปได้ในการปล่อย growth factor คอลลาเจน หรือสารต้านจุลชีพตามที่แผลต้องการ

Podipatch ได้ไป pitch ที่ NUS สิงคโปร์ ได้ Grand Finalist, NUS Medical Grand Challenge 2024 และที่จุฬาฯ ได้ Winner, MDCU Pitching Challenge 2025

ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับนวัตกรรม ไม่ได้อยู่ในเปเปอร์ แต่อยู่ตรงหน้าเราตอนราวด์วอร์ด

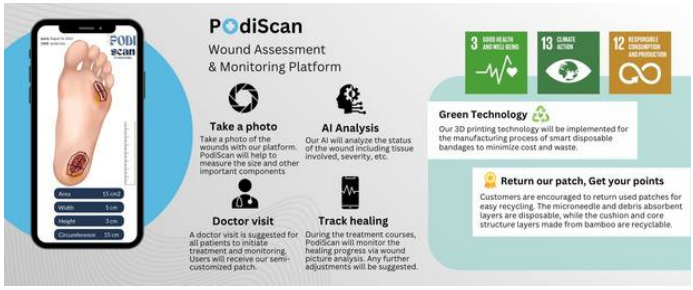
และผมอยากเป็นแพทย์ที่ไม่หยุดถามว่า “มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม”

PodiPatch — Smart Microneedle Sensor & Drug-Delivery Patch

Co-Founder & Team Lead — Ideation Stage with Feasibility Analysis

What is PodiPatch?





PodiPatch — a microneedle-based sensor & drug-delivery patch for diabetic foot ulcers.

PodiPatch เป็นแผ่นแปะที่ผสานเซนเซอร์ไมโครนีดเดิลเข้ากับระบบนำส่งยา สำหรับผู้ป่วยแผลเรื้อรังจากเบาหวาน ตัวเซนเซอร์วัดค่าที่บ่งชี้สถานะของแผล เช่น ระดับการอักเสบและตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อประเมินระดับการรักษาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันระบบนำส่งยาสามารถปล่อย growth factor คอลลาเจน หรือสารต้านจุลชีพ เพื่อกระตุ้นการสมานแผล

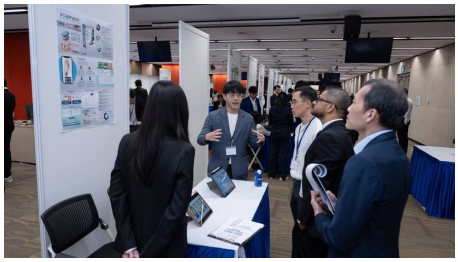
Awards & Recognition

🏆 Grand Finalist, NUS Medical Grand Challenge 2024

International health-tech pitching competition, National University of Singapore







🏆 Winner, MDCU Pitching Challenge 2025

Innovation Concept Pitching, hosted by Innovation Center (CMICe), Chulalongkorn University

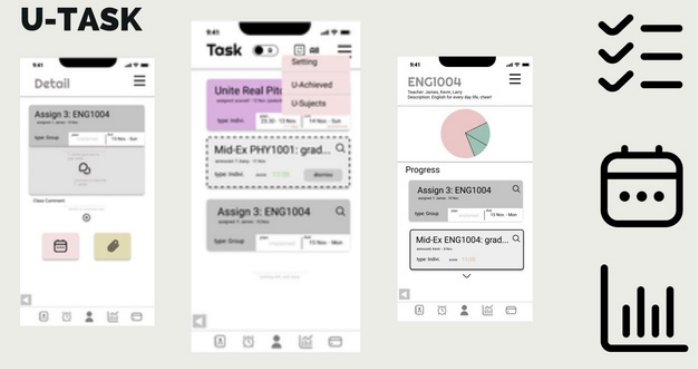




UNITE — AI-Powered Educational Platform for Medical Students

Founder & Team Lead — Prototype Stage

What is UNITE?



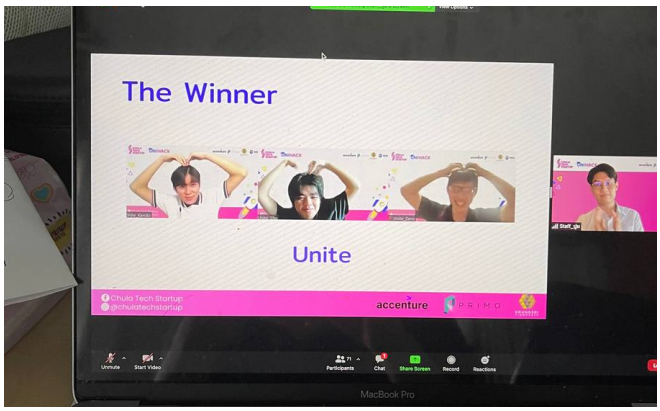
UNITE — an AI-powered educational platform for medical students.

UNITE เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาแบบครบวงจรสำหรับนักศึกษาแพทย์ ใช้ AI ช่วยจัดการตารางเรียน การบ้าน และสื่อการเรียน โดยรวบรวมแหล่งข้อมูลอย่าง Lecturio, PubMed และ AMBOSS ไว้ในแอปเดียว แบ่งเป็นสายพรีคลินิกและคลินิก พร้อมระบบฟีดแบ็กแบบเรียลไทม์ที่ติดตามทั้งคะแนนสรุปผลและคะแนนระหว่างทาง เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เหมาะกับจุดอ่อนและสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

Awards & Recognition

🏆 Winner, UniHack Hackathon 2021

Hosted by Chula Tech Startup, Chulalongkorn University





My takeaway

ในฐานะ Founder และ Team Lead ผมรับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบคอนเซปต์แพลตฟอร์มไปจนถึงลงมือเขียนโค้ดเองในฐานะ full-stack developer ช่วงแรก

UniHack เป็นสนามแข่งขันด้านเทคโนโลยีสนามแรกที่ผมได้เข้าร่วม ภายใน 48 ชั่วโมงต้อง refine ไอเดียร่วมกับเพื่อนในทีม ลงมือสร้างโปรโตไทป์จริง ตั้งแต่ทำ Photoshop mockup ทดสอบระบบ ลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล้า จนสุดท้ายได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประสบการณ์นี้สอนให้เห็นว่าการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันเวลาที่จำกัดต้องอาศัยการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน และเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจให้ผมคิดและทำนวัตกรรมต่างๆอีกหลายชิ้น

Trawell — Health-Focused Travel Planning Platform

Founder & CEO — Ideation Stage with Feasibility Analysis

What is Trawell?





Trawell — a health-focused travel planning platform for patients and wellness tourists.

Trawell เป็นแพลตฟอร์มวางแผนการเดินทางเชิงสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำหัตถการหรือหาคลินิกเวลเนสระหว่างเดินทาง มีฟีเจอร์ค้นหาคลินิก สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหารระหว่างทาง ช่วยเจรจาต่อรองประกันสุขภาพให้ได้ราคาที่ดีขึ้น พร้อมเครือข่ายแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และระบบรับประกันบริการพร้อม feedback ติดตามผล รวมถึงการจ่ายผ่านระบบเทเลเมดิซีน

Awards & Recognition

🏆 Qualified, Startup Thailand League Regional Pitch & Demo Day 2022

Awarded Top 5 Finalist, Mahidol University Startup Thailand League Competition







My takeaway

จุดเริ่มต้นของ Trawell มาจาก Class ปริญญาโท บริหารธุรกิจสุขภาพ ที่ได้โอกาสเรียนและฟังประสบการณ์จากผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และเห็นว่า Medical tourist ยังมีปัญหาในเชิงการใช้ชีวิต การ Follow up ผลการรักษา และการเข้าใจบริบทวัฒนธรรมไทย ที่มากไปกว่าการแค่หาที่พักหรือหาโรงพยาบาลที่จะมาทำการรักษา

ในฐานะ Founder และ CEO ผมเป็นเจ้าของไอเดียและนำทีมพัฒนา Trawell ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวางแผนการเดินทางแบบครบวงจร ตั้งแต่หาคลินิก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารระหว่างทาง ไปจนถึงเจรจาต่อรองประกันสุขภาพให้ได้ราคาดีที่สุด ร่วมกับเครือข่ายแพทย์ทุกสาขาเพื่อบริการที่มีคุณภาพและแข่งขันได้ พร้อมระบบรับประกันบริการและ feedback loop สำหรับติดตามผล รวมถึงการจ่ายผ่านระบบเทเลเมดิซีน

การนำ Trawell ไป pitch ในเวที Startup Thailand League ที่มหิดล สอนให้เห็นความสำคัญของการเล่าปัญหาที่จับต้องได้จากประสบการณ์จริง มากกว่าการนำเสนอฟีเจอร์เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว และทำให้ผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ดีที่สุดมักเริ่มจากการเข้าใจความยากลำบากของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างแท้จริง

Nirvamed — Cardiac Contrast-Removal MedTech

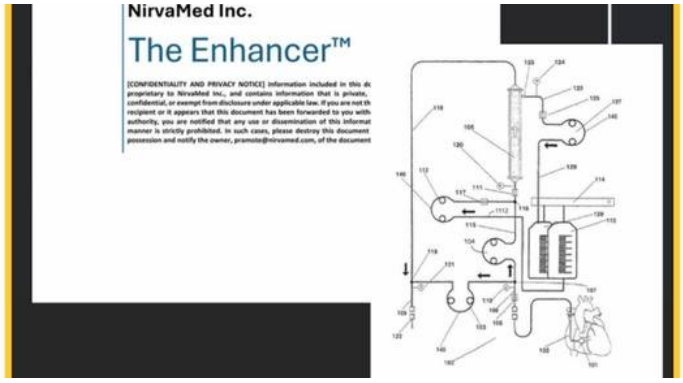
Business & Product Design Intern — May 2024–Present

What is Nirvamed?









Nirvamed เป็นสตาร์ทอัพด้าน Medtech, จดทะเบียนบริษัทที่ Minnesota, USA ที่พัฒนา Contrast removal system เทคโนโลยีสายสวนหัวใจที่ดักจับสารทึบรังสี (Contrast Media) ไว้ภายในหัวใจระหว่างทำหัตถการสวนหัวใจ เพื่อป้องกันสารทึบรังสีไหลไปทำร้ายไต ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนไข้โรคหัวใจร่วมกับโรคไตเรื้อรัง ก่อตั้งโดย ดร. ปราโมทย์ หอเจริญ
ปัจจุบันได้รับการลงทุนโดย BDMS, PTTGC, ศิริราชมูลนิธิ, SeaX Ventures, Valuation 5M USD

What I Did?

ในฐานะ Business & Product Design Intern ผมรับผิดชอบ 2 ด้านหลัก

ด้านธุรกิจ นำประสบการณ์จากปริญญาโทและการทำ Trawell/UNITE มาใช้จริงในการระดมทุนจากนักลงทุนและกลุ่มกองทุนต่างๆ ทำสไลด์พิตช์ และวางแผนธุรกิจระยะยาวให้บริษัท

ด้านผลิตภัณฑ์ ศึกษาเทคโนโลยี contrast removal จากต่างประเทศ พูดคุยกับบริษัทเทคโนโลยี Hemoadsorption เช่น Jafron จากประเทศจีนและปรึกษาอาจารย์วิศวกรรมและอาจารย์ด้าน interventional cardiology จากหลายสถาบัน เพื่อช่วยออกแบบเทคโนโลยี Contrast removal ให้ดักจับสารทึบรังสีในหัวใจไม่ให้ไปทำร้ายไต สร้าง Experimental question ทดลอง Idea และ Design Experiment เพื่อจดสิทธิบัตร ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับการจดสิทธิบัตรในสหรัฐ การขอ USFDA และการ Consultant กับบริษัทนานาชาติมากมาย

My takeaway

การฝึกงานที่ Nirvamed เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าได้เติบโตมากที่สุดในชีวิตนักศึกษาแพทย์ของผม เพราะ**ได้ทำงานทั้งด้านธุรกิจและนวัตกรรมไปพร้อมกันจริงๆ ไม่ใช่แค่ทฤษฎี ใน Implementation scale ระดับนานาชาติ** ทำให้เห็นทั้งข้อจำกัดของการระดมทุนด้าน medtech ในประเทศไทย และเห็นว่ามีวิธีฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นได้ เป็นบทเรียนที่สำคัญให้ผมเห็นว่าการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพสักชิ้นต้องผ่านความยากลำบากและต้องมีใจรักมากจริงๆ

Technology Leadership — Siriraj Medical Student Union

รองอุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคคล สายเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช (สพศ.)

Overview

ปีที่ 2 (2022)
- สมาชิกฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาบุคคล
- เสนอไอเดียและเป็น Head of Facilitator, Siriraj Hackathon
  MC, Research x Startup talk

ปีที่ 4 (2024)
- รองอุปนายกด้านเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาบุคคล
- จัดงาน Road to MedTech Career Path in Healthcare
- Content Creator, IG Personal Development SMSU Siriraj

🧑‍💻 นศพ. ปี 2 (2022) — Siriraj Hackathon

ตอนปี 2 เข้าเป็นสมาชิกฝ่ายเทคโนโลยีของฝ่ายพัฒนาบุคคล สพศ. ศิริราช ปีนั้นเป็นปีแรกที่มีฝ่ายพัฒนาบุคคล ผมเป็นรุ่นน้องปี 2 ที่มีพื้นฐานการแข่งขัน Hackathon จึงเสนอไอเดียจัด Hackathon ด้าน healthcare innovation ให้นักศึกษาแพทย์ และรับหน้าที่เป็น Head of Facilitator ดูแลทีมพี่เลี้ยงที่คอยช่วยกลุ่มผู้เข้าแข่งขันตลอดงาน งานนี้ได้เชิญผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ และ CEO ของ THE STANDARD มาเป็นวิทยากร



- ออกแบบโครงสร้างกิจกรรมและ timeline การแข่งขันร่วมกับทีมงาน
- คัดเลือกและอบรมทีม facilitator ก่อนวันงานจริง
- วางแผนธีมงานและติดต่อประสานงานวิทยากรระดับผู้บริหารและผู้ว่าฯ





🏆นศพ. ปี 4 (2024) — Road to MedTech Career Path in Healthcare

พอขึ้นปี 4 ได้รับเลือกเป็นรองอุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคคล สายเทคโนโลยี รับผิดชอบงานฝ่ายเทคโนโลยีทั้งหมดของ สพศ. งานใหญ่ที่สุดของปีนั้นคือการจัดงาน Road to MedTech Career Path in Healthcare เพื่อเปิดมุมมองอาชีพสาย health-tech ให้รุ่นน้อง ได้ติดต่อเชิญวิทยากรที่เป็น technology expert แต่มีเส้นทางสายแพทย์ต่างกันทั้ง 3 สาย ได้แก่ Clinical practice: ผศ. นพ. วรัชญ์ วรนิสรากุล, Medical startup: ดร. ปราโมทย์ หอเจริญ, Research: ศ.นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

- ประธานจัดงานและควบคุมดูแลภาพรวมของกิจกรรม
- วางแผนธีมงานและติดต่อประสานงานอาจารย์วิทยากรทั้ง 3 ท่าน
- บริหารทีมฝ่ายเทคโนโลยีและงบประมาณของกิจกรรม
- ดูแล content การให้ความรู้ผ่าน IG Personal Development SMSU Siriraj ควบคู่กันไป

Innovation & Technology — Startup Ecosystem

Additional Ventures & Coding Background

🏆 Member, Medcubator — Startup Incubator by TMSIC (2022)

1-year startup incubator program by Thai Medical Student Innovation Club (TMSIC), pairing medical students with mentors to turn a healthcare idea into a working concept and pitch



🏆 Selected, 42 Bangkok Cadet (2021)

1 of 120 selected out of 10,000 applicants for the Piscine — an intensive, peer-to-peer coding bootcamp with no teachers or lectures, based on 42's project-based curriculum



Innovation & Entrepreneurship — Additional Activities

กิจกรรมเพิ่มเติม — Additional Ventures & Roles

MonkeyEveryday — Back-End Dev (2020)
พัฒนาฐานข้อมูล MySQL และระบบ Learning Behavior Tracking ให้แพลตฟอร์ม Edtech

MSEC II Incubation Program (2022)
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ by Mahidol Startup Club

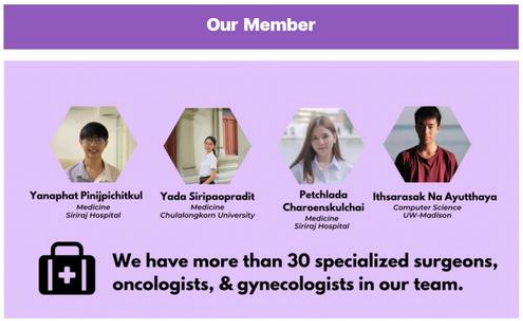
Finance Team, TMSIC (2022)
ร่วมทีมการเงินของ Thai Medical Student Innovation Club

CU Case Discovery — Open qualifier (2022)
ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 200+ ทีม

MC, Research x Startup Talk (2022)
พิธีกรงานเสวนา จัดโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช

Chula EXPO - UNIQLO case competition 2022
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน











Global Health & Public Health Initiatives

Overview

2023–ปัจจุบัน

VP & Co-founder ชมรม Global Health ของนักศึกษาแพทย์ศิริราช

2025–2026

เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม PMAC ต่อเนื่อง 2 ปี ในฐานะ Observer & Vice President



7	2	2023
Global Health Initiatives	PMAC Years Attended	VP Since

ในฐานะรองประธานชมรม Global Health และตัวแทนเข้าร่วมประชุม PMAC ผมได้เรียนรู้ว่าปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนต้องอาศัยมุมมองเชิงระบบ ไม่ใช่แค่ความรู้ทางคลินิกเพียงอย่างเดียว การได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทำให้ผมเห็นภาพใหญ่ของระบบสุขภาพ และตระหนักว่าตัวเองเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปทีละก้าว

Key Initiatives

- **1. VP & Co-founder — Siriraj Global Health Club (2023–ปัจจุบัน)**
  ร่วมก่อตั้งและบริหารชมรม Global Health ของนักศึกษาแพทย์ศิริราช
- **2. Vice President — Global Health Case Competition (PMAC side-event, 2024)**
  ดูแลการจัดแข่งขันและกระบวนการคัดเลือกทีมนักศึกษา
- **3. Indo-Pacific Case Competition — University of Melbourne (2024)**
  รับผิดชอบการคัดเลือกทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค
- **4. PMAC 2025 & 2026 — Observer & Vice President**
  รองประธาน PMAC Global Health Case Competition ติดต่อกัน 2 ปี
- **5. President — Siriraj Global Health Case Competition Unit (IPGHCC)**
  ก่อตั้งและดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบจัด case competition ด้าน global health โดยเฉพาะ
- **6. Field Work — สสจ.พิจิตร**
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์หยุดเผาป่าร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
- **7. Co-Founder, Issara Project — Community Health (2025)**
  ร่วมกับ Siriraj Hope Club และ NUS จัด Hypertension Screening Program ในชุมชน

Global Health — PMAC 2025



PMAC 2025 — Observer & Head of Case building team of PMAC Global health case competition (Jan 2025)

- **PMAC** (Prince Mahidol Award Conference) คือการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน global health จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
- ในฐานะ**รองประธานชมรม** Global Health รับผิดชอบ PMAC Global Health Case Competition 2025 (side-event) ในส่วนของ case building และ competition — บริหารทีม ประเมิน KPI/OKR รายเดือน ไปจนถึงออกแบบโจทย์และหา judge
- ปีนี้มีทีมเข้าร่วม 6 ประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 15 ทีม
- ศึกษาดูงาน **BDMS Field Trip “Exploring AI Healthcare Ecosystem in Thailand”**

นอกจากงาน side event ผมยังได้เข้าร่วม field trip ของ BDMS ได้เห็น AI ที่โรงพยาบาลเอกชนนำมาใช้จริง ทั้ง Preceptra-CXR ระบบ AI อ่านผล X-ray และ MOR-ASR ระบบ speech-to-text ที่ช่วยแพทย์ฟังประวัติคนไข้แล้วสรุปเป็นข้อความอัตโนมัติ ทำให้ process การซักประวัติเร็วขึ้นมาก

ส่วนใน main conference ได้ฟังเรื่อง genomic sequencing ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากทีมนักวิจัยจีน และได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์หลายท่านที่มาเป็นทั้ง speaker และ moderator ของงาน หนึ่งในนั้นคือ อ. Kiesha Prem จาก NUS Saw Swee Hock School of Public Health ที่พูดเรื่องนโยบายวัคซีนในกลุ่มประเทศรายได้น้อยถึงปานกลาง หลังจบทอล์กผมเดินเข้าไปคุยกับอาจารย์ จนได้รับโอกาสไปฝึกงานวิจัยด้าน stakeholder analysis เกี่ยวกับ HPV vaccination landscape ในลาวกับอาจารย์ต่อ

PMAC ในปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้ผมเห็นว่า Global health เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ได้เห็นนวัตกรรมต่างๆที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างให้กับมนุษยชาติ และผมมีศักยภาพมากพอในการช่วยขับเคลื่อนมัน

Global Health — PMAC 2026



PMAC 2026 — Observer & Vice President of PMAC Global health case competition (Jan 2026)

• ปีนี้ชมรม**ได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน PMAC Global Health Case Competition 2026 ทั้งหมด**ขอบเขตงานกว้างและละเอียดขึ้นจากปีก่อน
• นำ feedback ข้อบกพร่อง และ near-miss events จากปีที่แล้วมาออกแบบ workflow ใหม่ให้สมบูรณ์ขึ้น
• ตั้งเป้าหมายร่วมกับประธานชมรมเรื่อง **standardization** เพื่อผลักดันให้งานเป็น international มากที่สุด ยกระดับมาตรฐาน case question, judging system, ceremony และ venue management
• ปรับปรุง workflow ให้ lean ขึ้น วางโครงสร้างทีมทำงานใหม่ และส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องที่มา shadow งาน

ปีนี้ PMAC จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘Navigating Global Demographic Transition through Innovative Policy: An Equity-Centered Approach’ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ผมสนใจเรื่องอัตราการเกิดที่ลดลงเป็นพิเศษ เพราะเชื่อมโยงกับงานสูติ-นรีเวชที่กำลังเรียนอยู่

ปีที่แล้วเรียนรู้จากการลงมือทำ ปีนี้ต่อยอดวางแผนเชิงระบบให้งานดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ

มองว่าอะไรที่เคยพลาดและจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เป็นการฝึกภาวะผู้นำแบบที่ไม่ใช่แค่บริหารงานเฉพาะหน้า แต่ต้องออกแบบระบบให้ยั่งยืนสำหรับทีมรุ่นต่อไป

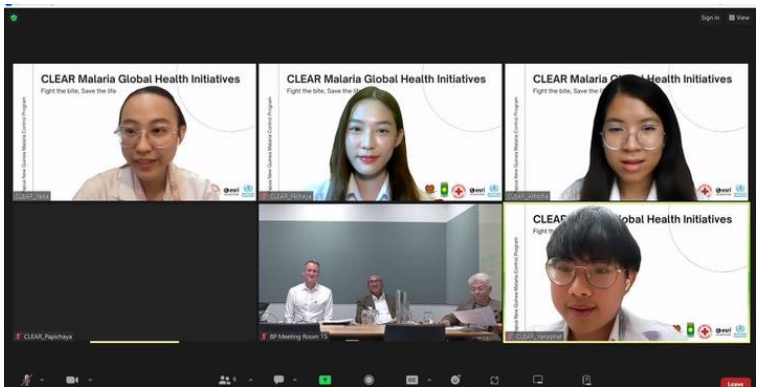
Global Health — Case Competition Ecosystem



01 · CURASI — Co-organizer & Workshop Lead (CU + RA + SI)

CURASI เป็นงานที่ชมรม Siriraj Global Health ริเริ่มเอง ประสานกับจุฬาฯ และรามาธิบดี (CU+RA+SI) เชิญ อ.เจษฎ์ เลขาธิการ สปสช. มาบรรยาย UHC พร้อม case simulation workshop ให้นักศึกษาแพทย์ 3 สถาบันร่วมกันแก้โจทย์ — ผมดูแลส่วน workshop และการบริหารจัดการทั้งหมด





02 · IPGHCC — Chulalongkorn Team Representative, University of Melbourne

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมจุฬาฯ ไปแข่ง International Public and Global Health Case Competition (IPGHCC) จัดโดย University of Melbourne แข่งกับทีมนักศึกษาจากหลายประเทศภายใต้โจทย์ปัญหาสุขภาพระดับโลกปีนี้จัดใน Theme Malaria transmission in Papua New Guinea

งานนี้ทำให้ผมเห็นว่าการแข่งระดับนี้ต้องอาศัยทั้ง healthcare background และทักษะ case-solving ที่ฝึกกันได้ ผมได้รับแรงบันดาลใจจากฝั่ง Business case sompetition มักจะมี Case club ที่บ่มเพาะ Skill ต่างๆพวกนี้อย่างเข้มข้น แต่ในส่วนของ Global health case competition ยังไม่มี Club แบบนี้อยู่จึงกลับมาตั้ง Global health Case Competition Unit ขึ้นมาในชมรมและผมก็รับหน้าที่เป็นประธานออกแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อมคัดเลือกนักศึกษามหิดลเพื่อไปแข่ง IPGHCC ในปีถัดๆไป

My takeaway

ทั้งสองงานนี้ทำให้ผมเห็นว่า Global health awareness ในนศพ. ไทยเนี่มมีมากขึ้นและผมดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยขับเคลื่อนมัน

ตอนจัด CURASI ผมเห็นว่านักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 สถาบันกระตือรือร้นกับ Case Simulation มาก แต่แทบไม่มีใครเคยฝึกแบบเป็นระบบมาก่อน พอไปแข่ง IPGHCC ที่ Melbourne จริงก็ยิ่งเห็นชัดว่าทีมจากประเทศที่มีโครงสร้าง Case Club เตรียมตัวมาดีกว่าทีมที่ไม่มีมากแค่ไหน ในขณะที่ฝั่ง Global Health แทบไม่มีโครงสร้างแบบนี้เลยในไทย ผมเลยกลับมาตั้ง Global Health Case Competition Unit ขึ้นเอง เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มวางระบบตรงนี้ ก็จะผลักดันให้ Global heath โดยเฉพาะใน Part case competition เข้าถึงรุ่นน้องปีถัดๆไปได้ง่ายและน้องๆก็จะเก่งพอทีจะไปทัดเทียมกับนานาชาติได้

CHAPTER · GLOBAL HEALTH

2 อาทิตย์ที่เปลี่ยนมุมมองเรื่องระบบสุขภาพ

Public Health Elective · Phichit Province · 2025

ผมไป elective ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้ว่า ‘ระบบสาธารณสุข’ ทำงานอย่างไร แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการเข้าใจว่า นโยบายที่ดีจะเกิดขึ้นจริงได้ ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจคนและบริบทที่ต้องนำไปปฏิบัติจริง

วันแรก ๆ ผมเริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้าง ฟังบรรยาย hierarchy กระทรวงตั้งแต่ปลัดถึงสาธารณสุขอำเภอ ดูโครงการ One Province One Hospital และดูงานเหมืองทองอัครา สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ

> **“นโยบายบนกระดาษล้มเหลวได้เสมอ ถ้าไม่เข้าใจบริบทของหน่วยที่ต้องเอาไปทำจริง”**

จุดที่ประทับใจที่สุดคือวันที่ท่าฬ่อ ประชุมโครงการขจัดความยากจนร่วมกับนายอำเภอ นายกเทศบาล เจ้าอาวาส และ อสม. บรรยากาศในที่ประชุมเครียดมากเพราะงบประมาณมีจำกัด และเราไม่ได้แก้แค่ปัญหาสุขภาพ แต่ต้แงแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ทุกคนไม่เชื่อว่าจะทำได้ จนอาจารย์วิสิษฐ์พูดประโยคที่ผมจำมาถึงตอนนี้ **“ต้องทุ่มความพยายามไปที่จุดแข็งของเรา ไม่ใช่ทุ่มไปกับการปิดจุดอ่อนทั้งหมด เพราะเราไม่มีวันปิดจุดอ่อนได้ครบ”**

วันสุดท้ายผมได้มีโอกาสพูดสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ ซึ่งยากกว่าที่คิด เพราะผมโตมาในกรุงเทพฯ และด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นแพทย์ แต่นักเรียนที่นี่ยังไม่มีภาพนั้นชัดเจน จึงเลือกยกตัวอย่างจากเพื่อนที่มีพื้นเพใกล้เคียงนักเรียนมากกว่า ทำให้น้องๆเข้าใจและรับฟังข้อความที่ผมมากขึ้น

2 อาทิตย์นี้ทำให้ผมอยากเป็นแพทย์ที่ไม่ได้ Focus แค่การรักษา แต่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไปพร้อมๆกัน

Global Health — Pichit Elective

ภาวะผู้นำ นโยบาย และธรรมาภิบาลสาธารณสุข







- Courtesy call กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (นพ.วิสิษฐ์) — เปิดหัวข้อภาวะผู้นำและการสื่อสาร
- ฟังบรรยาย hierarchy กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปลัดกระทรวงถึงสาธารณสุขอำเภอ
- ศึกษาโครงการ One Province One Hospital — รวมทรัพยากรโรงพยาบาลทั้งจังหวัด
- ดูงานเหมืองทองอัครา — เห็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน

MY TAKEAWAY

สิ่งที่ผมได้จากการติดตาม อ.วิสิษฐ์คือ character สำคัญกว่า personality ในการเป็นผู้นำและการโน้มน้าวสำคัญกว่าการสั่งการเสมอ การได้เห็น hierarchy ของกระทรวงสาธารณสุขทำให้เข้าใจว่าทำไมนโยบายที่ดีบนกระดาษถึงนำไปปฏิบัติจริงได้ยาก ไม่ใช่เพราะคนไม่ตั้งใจ แต่เพราะแต่ละชั้นมีบริบทและข้อจำกัดต่างกัน และ evidence-based policy อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีแรงสนับสนุนทางการเมืองรองรับด้วยเสมอ

งานภาคสนามชุมชน — บวร (บ้าน วัด ราชการ)





- ร่วมกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด ราชการ) ผ่านเครือข่ายวัดและ อสม.

MY TAKEAWAY

พื้นที่ชนบท วัดและ อสม. คือหัวใจของงานสาธารณสุขเชิงรุก เป็นสะพานเชื่อมนโยบายกับชุมชนที่มีประสิทธิภาพกว่าการสื่อสารจากส่วนกลางตรงๆ และการควบคุมโรคที่ดีต้องเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาทางสุขภาพไม่เคยแยกขาดออกจากปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา — หลังจบ Elective นี้**ผมจึงริเริ่มโครงการ Health Management Elective Unit** เพื่อวางแนวทางอิเล็กทีฟด้าน Global Health ให้รุ่นน้องต่อไป

Global Health — Pichit, Community

ท่าฬ่อโมเดล — ขจัดความยากจนและยาเสพติด





• ประชุมขจัดความยากจนที่ท่าฬ่อ ร่วมกับนายอำเภอ นายกเทศบาล เจ้าอาวาส และ อสม. บรรยากาศเครียดมากเพราะงบมีจำกัด ปัญหาไม่ใช่แค่สุขภาพ แต่รวมยาเสพติดและความยากจนด้วย
•ได้ลงไปเห็นพื้นที่ชุมชนที่มีปัญหาจริงๆ ทำให้เห็นว่าการจะแก้ปัญหาสุขภาพได้ต้องคำนึงถึง Holistic care ด้านอื่นๆ จึงจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
• เยี่ยมบ้าน 8 หลัง 3 ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวรายได้ไม่มั่นคงและผู้ป่วยติดยาเสพติด ซึ่งต่างจากการเยี่ยมบ้านที่เคยได้ไปมามากๆ เนื่องจากปกติการเยี่ยมบ้านจะโฟกัสที่การรักษาและควบคุมตัวโรค แต่การเยี่ยมบ้านครั้งนี้ไปเพื่อออกแบบนโยบายเชิงสุขภาพ จึงมีจุดที่ได้เรียนรู้ต่างกันมากๆ

รณรงค์หยุดเผาป่า ลดฝุ่นควัน





• ร่วมรณรงค์หยุดเผาป่ากับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ท่าฬ่อ ผมมีความรู้สึกตลอดเวลาไปลงชุมชนที่ต่างจังหวัดว่าฝุ่น PM 2.5 เป็น Social determinants of health ที่สำคัญและผู้คนในพื้นที่แทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย การร่วมรณรงค์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาที่ใหญ่และส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนขนาดนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องจริงๆ

Inspiration Talk — โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ





• พูดสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ ยากกว่าที่คิดไว้มาก เพราะผมโตมาในกรุงเทพฯ พร้อมความคาดหวังว่าจะเป็นแพทย์มาตั้งแต่เด็ก แต่นักเรียนที่นี่ยังไม่มีภาพนั้นชัดเจนเหมือนกันเลยเปลี่ยนมายกตัวอย่างจากเพื่อนร่วมทีมที่มีพื้นเพใกล้เคียงนักเรียนมากกว่าแทน ทำให้น้องๆเข้าใจและรับฟังสิ่งที่ผมพูดมากขึ้น

International & Clinical Exposure

Overview

2023

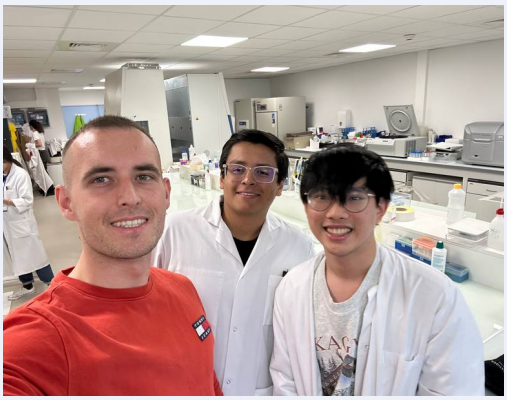
IFMSA Research Exchange ที่ Marseille เริ่มต้นเส้นทางแลกเปลี่ยนนานาชาติ

2025–2026

Elective คลินิกที่สิงคโปร์ (NUH/NUS) และ Elective OB/GYN ในไทย

2027

DUKE university, Clinical OB/GYN elective



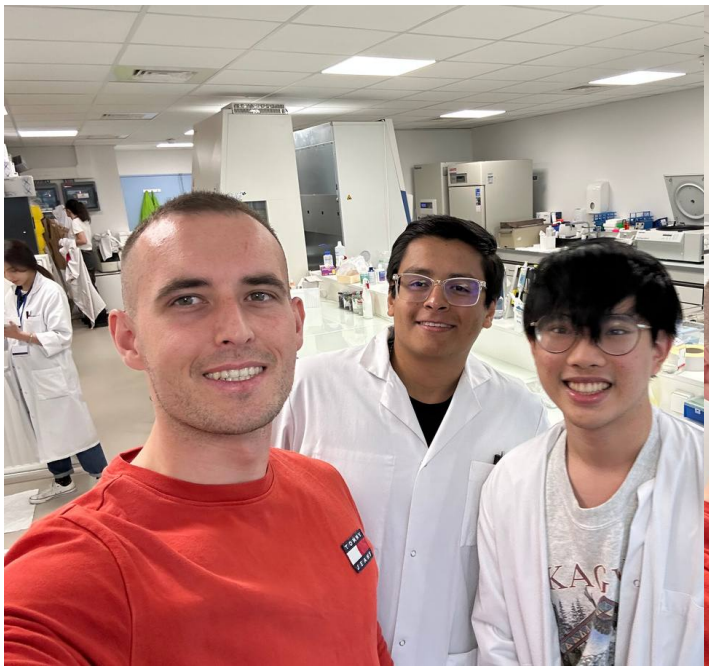
9	3	2027
Total Experiences	Countries Visited	Next: Duke University

ประสบการณ์ International Exposure เหล่านี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุด เพราะทุกครั้งที่ไป Elective ผมผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมด ไม่ใช่แค่สมัครแล้วไปเฉยๆ ผมเริ่มมีความกล้าแสดงออกและ International connection skills มาตั้งแต่ตอนมัธยม ตอนที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน International Physics Olympiad และ International Astronomy Olympiad ก่อนจะต่อยอดมาสู่เวทีวิชาการและคลินิกระดับโลกตอนเรียนแพทย์ การไป Electives ต่างๆเหล่านี้ทำให้ผมทำลายกำแพงข้อจำกัดของตัวเอง เห็นว่าตัวเองสามารถเติบโตได้มากกว่าที่เป็นอยู่จากการได้ไปเห็นมาตรฐานระดับโลก

Key Experiences

- **1. Marseille, France — IFMSA Research Exchange (2023)**
  ได้รับการคัดเลือกจาก IFMSA ไปแลกเปลี่ยนวิจัยที่ Aix-Marseille Université จุดเริ่มต้นของความสนใจด้าน global health
- **2. NUH, Singapore — Clinical Exchange (2025)**
  ได้รับการคัดเลือกจากศิริราชดูงานผ่าตัด Ortho & Plastic Surgery ที่ NUH, NUS, Singapore
- **3. NUS, Singapore — Public Health Research Internship (2025)**
  Stakeholder analysis ของ HPV vaccination landscape ในลาว ที่ Saw Swee Hock School of Public Health
- **4. Duke University — OB/GYN Elective (2027, pending)**
  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศิริราชไปแลกเปลี่ยนทางคลินิก OB/GYN ที่ DUKE University, เมษายน 2027
- **5. International Physics & Astronomy Olympiads — Foundation (2017–2019)**
  Foundation ของความกล้าแสดงออกและ Interpersonal skill
- **6. Prince of Songkla University — OB/GYN Elective (2026)**
  Elective สูติ-นรีเวช 2 สัปดาห์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- **7. Thammasat University — OB/GYN Elective (2026)**
  Elective สูติ-นรีเวช 2 สัปดาห์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **8. Siriraj Hospital — OB/GYN Elective (2026)**
  Elective สูติ-นรีเวช 2 สัปดาห์ ที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- **9. SIGJ — OB/GYN Elective (2026)**
  Elective สูติ-นรีเวช 2 สัปดาห์ ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

International Experience — Marseille, France





IFMSA Research Exchange Program — “Role of placenta cell during Infection” Aix-Marseille Université (2023), IFMSA SCORE funded , 1 out of 12 selected

• โครงการแลกเปลี่ยนงานวิจัยของ IFMSA ที่ Aix-Marseille Université ประเทศฝรั่งเศส เป็นงานวิจัยเพื่อดู Role of placenta cell during infection ที่ต่อยอดมาจากงาย “From Coxiella burnettii Infection to Pregnancy complications: Key role of the immune response to Placental Cells” เมษายน–พฤษภาคม 2023
• ทำงานร่วมกับทีมวิจัยในโรงพยาบาลและ Lab ของ Aix-Marseille Universite ได้ทำ Cell culture, PCR, Prepare specimen for Electron Microscope และได้มีโอกาส observe clinical rotation ของ Labor room

My takeaway

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นระบบพยาบาลของต่างประเทศ ได้สัมผัสทั้งประสกาบรณ์ทางคลินิกและทำวิจัยในห้องแล็บ ได้ตั้งคำถามกับการตัดสินใจต่างๆเชิงระบบสุขภาพที่ต่างจากประเทศไทย หลังจากกลับมาที่ประเทศไทย**ผมจึงชวนเพื่อนก่อตั้งชมรม Global Health ของศิริราช** เพราะอยากมีพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์คนอื่นได้ตั้งคำถามแบบเดียวกันบ้าง

นอกจากนี้ประสบการณ์ที่ได้ไปช่วยทำงานวิจัยก็ทำให้ผมได้ฝึกคิด Research question ได้ฝึก Labaratory skill ต่างๆกับเครื่องมือที่ทันสมัย และทำให้ผมได้มี Connection กับเพื่อนๆนักศึกษาแพทย์ต่างชาติเป็นครั้งแรก



IFMSA
International Federation of Medical Students' Associations

Certificate

This document certifies that the medical student
Yanaphat Pinijpichitkul from Thailand
has successfully completed their research exchangeentitled
Role of placenta cells during infection
in the department of Aix-Marseille University MEPHI IHU Mediterranean infection 19-21
Boulevard Jean Moulin 13005 MARSEILLE,
at France (ANEMF)- Marseille University
during the period Apr 2023 - Apr 2023 under the supervision of
Pr. Jean-Louis MEGE and Dr. Soraya MEZOUAR

The student has fulfilled the requirements for research exchange according to the regulations of the Standing Committee on Research Exchange (SCORE) of the International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA).

ANEMF FRANCE

Chonmarnitthese Chinapisutt
Wachirawit Angkatavanich

IFMSA International Secretariat, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam, the Netherlands
www.ifmsa.org gs@ifmsa.org KVK: 34139641

International Experience — NUH, Singapore



Clinical Exchange — Orthopedic & Plastic Surgery, NUH / NUS (2025)
Siriraj international relations funded exchange program, 4 out of 15 selected

- Clinical electives 2 สาขา— Orthopedic surgery และ Plastic surgery ที่ National University Hospital (NUH), NUS สิงคโปร์ กุมภาพันธ์–มีนาคม 2025
- เข้าห้องผ่าตัด ward round และ OPD ร่วมกับทีมแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์ในระบบของสิงคโปร์
- เห็นการจัด workflow การส่งต่อผู้ป่วย และการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่

My takeaway

ก่อนขึ้นปี5 ผมได้ไปแลกเปลี่ยนที่ NUH สิงคโปร์ นอกจาก Part clinical ที่ได้รับประสบการณ์และเห็นบริบทสังคมผู้อายุเต็มรูปแบบแล้ว **สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือระบบ HIS ที่เชื่อมทุกระบบใน รพ.**เข้าด้วยกัน ตั้งแต่ OPD ห้องผ่าตัด ห้องทำแผล เวชระเบียน ไปยัง application ในมือถือของคนไข้เอง จากที่ผมเคยคิดว่าศิริราชมีโทคโนโลยีที่ค้อนข้างทันสมัยแล้ว ก็ทำให้ผมเห็นว่าศิริราชก็ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาต่อได้อีก เพื่อให้คนไข้ได้รับบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้สิ่งที่ผมได้กลับมามากๆคือแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง นักศึกษาแพทย์สิงคโปร์ที่ผมเจอ น้องปี 2-3 บางคนมีงานวิจัยตีพิมพ์แล้ว 3-4 ฉบับ เตรียมสอบ USMLE กันเกินครึ่ง Class **ทำให้ผมอยากผลักดันตัวเองมากขึ้น กลับมาศิริราชผมเลยตั้งใจทำชมรมและกิจกรรมวิชาการต่อในปี 5 ให้เข้มข้นกว่าเดิม**

CHAPTER · INTERNATIONAL & CLINICAL EXPOSURE

โอกาสไม่ใช่แค่โชค

Health Research, NUS · 2025–2026

สองปีที่ผมดูแล PMAC Global Health Case Competition ในฐานะรองประธานชมรม Global Health เป็นงานเบื้องหลังเกือบทั้งหมด ตั้งแต่ออกแบบโจทย์ หา judge ไปจนถึงประเมินทีมในแต่ละเดือน

ตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่างานพวกนี้จะพาผมไปที่จุดไหน จนวันหนึ่งผมได้มีโอกาสนั่งฟัง Dr. Kiesha Prem บรรยายในงาน PMAC

> **“โอกาสไม่ใช่แค่โชค ถ้าเราพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พร้อม โอกาสจะตามมา และเราต้องกล้าคว้ามันไว้”**

หลังจบ session ผมไม่ได้เดินออกไปเฉย ๆ ผมเดินเข้าไปแนะนำตัวกับอาจารย์ และถามว่ามีโอกาสได้เข้าไปช่วยงานด้วยไหม สองเดือนต่อมา ผมได้ไปทำงานที่ Saw Swee Hock School of Public Health, NUS

ตลอดสองสัปดาห์ที่นั่น ผมทำ stakeholder analysis เรื่อง HPV vaccination coverage ใน สปป.ลาว ไล่ตั้งแต่คนที่ได้รับผลกระทบ ไปจนถึงหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจจริง สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละฝ่ายมองปัญหาคนละมุม บางหน่วยงานให้ความสำคัญกับงบประมาณ ขณะที่บางหน่วยงานกังวลเรื่องความเชื่อและบริบททางวัฒนธรรม สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือ evidence ที่ดีอย่างเดียวไม่ได้ทำให้นโยบายเกิดขึ้นได้เสมอไป เราต้องเข้าใจคนที่อยู่รอบ ๆ นโยบายนั้นด้วย และทำให้พวกเขาเห็นว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ

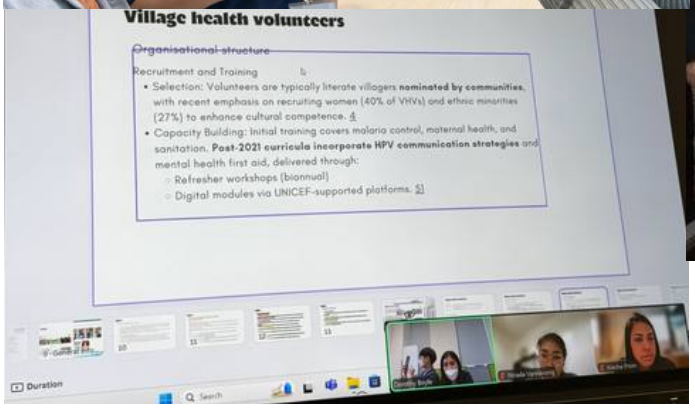
> **ก่อนหน้านั้น global health เป็นคำที่สำหรับผมฟังดูค่อนข้างไกลตัว เหมือนเป็นพื้นทีของคนที่มีประสบการณ์มากกว่าผม**

แต่สองสัปดาห์ที่ NUS ทำให้ผมมองมันต่างออกไป ผมเริ่มเห็นว่าการทำงานด้าน global health ไม่ได้ไกลเกินตัวอย่างที่เคยคิด แค่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม แล้วกล้าเดินเข้าไปหาโอกาสเมื่อมันมาถึง

International Experience — Public Health electives, Saw Swee Hock school of public health, NUS.







Public Health Research Internship — Saw Swee Hock, NUS (2025)

• ฝึกงานวิจัยสาธารณสุข 2 สัปดาห์ ที่ Saw Swee Hock School of Public Health, NUS ภายใต้การดูแลของ Assoc. Prof. Kiesha Prem

• ทำ Overview analysis, stakeholder analysis, feasibility analysis และ Draft implementation plan ของ HPV vaccination landscape ในประเทศลาว

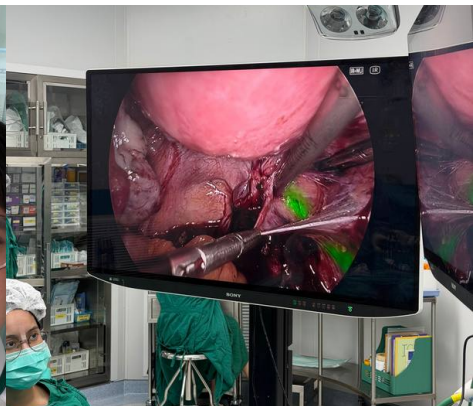
My takeaway

ตอนแรกนึกว่างานวิจัยสาธารณสุขคงเป็นแค่การเก็บข้อมูลกับเขียนรายงาน แต่พอได้ลงมือศึกษาบริบทของลาวจริงๆ ทั้งผู้นำชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ถึงเข้าใจว่างานแบบนี้ต้องคิดเป็นระบบทั้งภาพใหญ่ ไม่ใช่แค่มองที่ตัวเลข Coverage อย่างเดียว โดยเฉพาะตอนที่เทียบบริบทของลาวกับบริบทไทยที่หลายด้าน โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม คล้ายกันมาก ทำให้เห็นว่าโมเดลที่อาจารย์ Kiesha ทำสำเร็จในลาว เช่นการใช้ผู้นำชุมชนในแต่ละท้องถิ่น campaign การรณรงค์ผ่านวิชาสุขศึกษาทั่วประเทศในเชิงรุก อาจเอามาปรับใช้กับไทยได้จริง งาน 2 สัปดาห์นี้เลยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฝึกคิดแบบ Health System และ Public Health อย่างเป็นระบบจริงๆ

Clinical Electives — OB/GYN (2026)







Prince of Songkla University — OB/GYN Elective (2026)

- อิเล็กทีฟสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 สัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เคสที่เห็นบ่อยกว่าศิริราชคือ complications จากการฝากครรภ์ไม่สม่ำเสมอ เพราะคนไข้หลายคนเดินทางจากอำเภอรอบนอกมาไกล ระบบส่งต่อที่นี่จึงต้องคิดเรื่องระยะทางเป็นตัวแปรหลักตั้งแต่แรก ไม่ใช่แค่ severity ของโรค





Thammasat University — OB/GYN Elective (2026)

- อิเล็กทีฟสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 สัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เปรียบเทียบระบบการเรียนการสอนและแนวทางการดูแลผู้ป่วยกับศิริราช เห็นมุมมองการฝึกสูติ-นรีเวชที่หลากหลายขึ้น

Additional Exchanges & Roles

Duke University — OB/GYN Elective (2027, pending)

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศิริราชไปแลกเปลี่ยนทางคลินิก เมษายน 2027

OB/GYN Elective — ศิริราชพยาบาล (2026)

อิเล็กทีฟสูติ-นรีเวชภายในสถาบัน 16-27 มี.ค. 2026

OB/GYN Elective — ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (2026)

อิเล็กทีฟสูติ-นรีเวช 2 สัปดาห์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 18-30 ต.ค. 2026

SCORE Local Exchange Selection Team, IFMSA (2023)

ร่วมคัดเลือกนักศึกษาแพทย์เข้าโครงการแลกเปลี่ยนวิจัยต่างประเทศ

Community Service, Volunteer & Other activities

Overview

2024–2025

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่สังขละบุรี กาญจนบุรี
จัดทำวีดีโอสอนการฉีดอินซูลิน

2025

ร่วมก่อตั้ง Issara Project และดำรงตำแหน่ง
เลขานุการ SISC



3
Volunteer Projects

2
Provinces Reached

2025
Latest: Issara Project

ตอนเรียนหมอ เราถูกสอนให้วินิจฉัยโรค แต่ไม่มีใครสอนว่าจะคุยกับคนไข้ที่พูดไทยไม่ได้ยังไง หรือจะเข้าถึงคนที่ระบบสุขภาพมักมองข้ามได้ยังไง งานอาสาและการลงชุมชนคือสิ่งที่เติมช่องว่างตรงนี้ให้ผม ทำให้เห็นคนไข้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่นอกโรงพยาบาล ไม่ใช่แค่เคสในตำรา และหลายปัญหาก็แก้ไม่ได้ถ้านั่งรออยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียว ต้องเดินออกไปหา

เริ่มจากค่ายแพทย์เคลื่อนที่ที่สังขะบุรีตอนปี 4 ต่อด้วยงานสาธารณสุขชุมชนที่พิจิตร ก่อนจะเริ่มทำโครงการเองบ้างอย่าง Issara Project และ HPV self-test แต่ละงานให้บทเรียนคนละแบบ แต่สรุปได้เหมือนกันคือ การลงพื้นที่จริงสำคัญมาก

Key Highlights

- **1. Community Health Volunteer — สังขละบุรี (2024–2025)**
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และวีดีโอสอนการฉีดอินซูลิน
- **2. Co-Founder — Issara Project (2025)**
  ร่วมกับ Siriraj Hope Club และ NUS จัดโครงการคัดกรองความดันโลหิตสูง
- **3. HPV Self-Test Community Project**
  ร่วมกับ พม. เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชน
- **4. Secretary — Siriraj Student Committee (SISC, 2025)**
  เลขานุการคณะกรรมการนักศึกษาศิริราช
- **5. Event Staff — Nice(2) Meet You Salaya (2022)**
  ร่วมทีมสตาฟกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
- **6. Event Staff — Siriraj Family Concert (2023)**
  ร่วมทีมสตาฟจัดการคอนเสิร์ตประจำปีของคณะ

Community Service — Issara Project











Co-Founder — Issara Project (2025)

โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและให้ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนคลองเตย จัดร่วมกันโดย Siriraj Hope Club, NUS, Bangkok Community Health Foundation และ Arirak Clinic

ที่มาของโครงการ

ผมเจอรุ่นน้องคนไทยที่เรียนแพทย์อยู่ที่ NUS สิงคโปร์ พูดคุยกันจนทราบว่าทาง NUS มีทุนสนับสนุนให้นักศึกษาไปทำโครงการจิตอาสาในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา เวียดนาม ผมจึงชวนน้องว่าถ้าอยากทำที่ไทย กลับมาทำร่วมกับศิริราชไหม ประกอบกับช่วงนั้นเพื่อนผมกำลังตั้งชมรม Siriraj Hope Club อยู่พอดี ผมเลย**ได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมออกแบบโครงการและประสานงานระหว่างเพื่อนที่ศิริราชกับรุ่นน้องที่ NUS จนกลายเป็น Issara Project** ที่ผมดูแลในฐานะ Co-founder เลือกลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยเพราะเป็นชุมชนที่เข้าถึงบริการสุขภาพยากและอยู่ไม่ไกลจากศิริราช เหมาะกับการเริ่มโครงการนำร่องที่ทั้งสองฝ่ายดูแลต่อเนื่องได้จริง

Community Service — Sangkhlaburi





Kong Mong Ta Health Promotion Campaign (2025)





Mobile Medical Unit — Ban Dong Yang Refugee Camp (2025)

ออกตรวจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยให้ความรู้ รวมทั้งจัดสต็อกยา บริเวณแคมป์ผู้ลี้ภัยบ้านดอนยาง ชุมชนผู้ลี้ภัยสงครามสัญชาติพม่าในหุบเขา





Health Promotion VDO (3 Dialects) & Outstanding Project Award

ทำวีดีโอ 3 ภาษา (ไทย มอญ พม่า) สอนการฉีดอินซูลินอย่างปลอดภัย ได้รับรางวัลผลงานโดดเด่น รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ

ตอนถ่ายวีดีโอ ปัญหาไม่ใช่แค่แปลภาษา แต่คือหาล่ามที่เข้าใจศัพท์ทางการแพทย์พอจะแปลให้ถูกต้อง สุดท้ายต้องนั่งอธิบายทีละขั้นตอนกับล่ามก่อนถ่ายจริง ถึงจะมั่นใจว่าคนไข้จะเข้าใจตรงกับที่เราตั้งใจสื่อสาร



Other Activities ภายใน, ภายนอก ศิริราช





เลขานุการ — กรรมการรุ่น ชั้นปี 4 (SISC), 2024-2025





Event Staff — Nice 2 meet sala(ya) & Siriraj Family Concert (2023)







อาสาสมัครสอน CPR/BLS — โครงการ "CPR ปั๊มเหอะพี่ขอ" (2026)

จัดโดย Lido Connect และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กิจกรรมเพิ่มเติม — Additional Activities & Roles

สมาชิกฝ่ายกิจกรรม — รับน้องข้ามฟาก (2023)

คณะผู้จัดทำ VDO ส่งเสริม HPV Screening ร่วมกับ อ.ปนิชา (2025)

ผลิตสื่อวีดีโอให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV self-test

Staff - Siriraj Dermatology Club Workshop (พ.ย. 2025)

Staff - โครงการพี่พาน้องขึ้นวอร์ด ครั้งที่ 10 (ธ.ค. 2023)

International & National Academic Olympiads (2560–2562)

IPhO 50 เหรียญทองแดง · IAO XXII เหรียญทองแดง · APhO 20 Honorable Mention · Thailand Physics Olympiad 17 เหรียญทอง · Thailand Astronomy Olympiad 14 เหรียญทองอันดับ 2 · กรรมการนักศึกษาแพทย์ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2566

